BC3 – Chapitre 6 : tout ce qu'il faut savoir

Éthique et déontologie en santé publique – fiche complète (à jour au 1er novembre 2026)

Mode d'emploi

Cette fiche résume tout le chapitre 6 : morale, éthique, déontologie et droit ; principes éthiques et principes de santé publique ; échelle d'intervention et nudge ; stigmatisation ; cadre de la profession ; secret professionnel ; RGPD ; consentement et droit à l'image ; conflits d'intérêts ; démarche de réflexion éthique ; droits des usagers ; responsabilité en atelier ; allégations, marketing et compléments ; enquêtes et recherche ; numérique et e-réputation ; dilemmes ; laïcité ; fil rouge, cas guidé, approfondissements et méthodes d'épreuve. Elle suit l'ordre du cours (6.3.1 à 6.9).

Corrections du fascicule CNED (Environnement professionnel, Les essentiels, 2e année, © 2022) à appliquer :

- **Droit à l'oubli** : ce n'est plus 10 ans mais **5 ans après la fin du protocole thérapeutique**, sans rechute, pour les cancers et l'hépatite C (**loi Lemoine du 28 février 2022**, applicable le 1er juin 2022).
- **Action de groupe** : le régime de 2016 a été remplacé par un **régime unique** (**loi du 30 avril 2025**, pour les actions introduites depuis le 2 mai 2025).
- La loi « HSPT » du fascicule est la loi **HPST** (« Hôpital, patients, santé et territoires ») du **21 juillet 2009**.
- **Pas de code de déontologie publié par décret ni d'ordre** pour les diététiciens : le texte de référence est la **charte de déontologie de l'AFDN (1er janvier 2018)**.
- **Consentement aux soins ≠ base légale des données** : en atelier ou en enquête, les données reposent souvent sur une autre base que le consentement, mais **l'information des personnes reste obligatoire**.

Autres mises à jour et précisions :

- **Contrôles des aliments** : depuis le **1er janvier 2024** (police unique de la sécurité sanitaire des aliments), l'**hygiène et la sécurité sanitaire** des aliments sont contrôlées par le ministère de l'Agriculture (DGAL et services départementaux). La **DGCCRF** garde l'**étiquetage, les allégations, la publicité, les pratiques commerciales trompeuses et l'influence commerciale**.
- **Morceau de sucre** : le cours compte 4 g dans un exemple (6.3.11) ; on garde le repère du chapitre 5, **1 morceau ≈ 5 g**. 11,2 g de sucres ≈ **2 morceaux** de 5 g (≈ 3 morceaux de 4 g).
- **IA** : règlement (UE) **2024/1689**. Interdictions depuis le 2 février 2025, modèles à usage général depuis le 2 août 2025, **transparence depuis le 2 août 2026** ; selon la veille du cours (26 octobre 2026), les obligations « haut risque » sont reportées au 2 décembre 2027 et au 2 août 2028.
- **Contribution sur les boissons sucrées** : créée en 2012, rendue progressive en 2018, **relevée le 1er mars 2025**.
- **Déclaration d'Helsinki** : dernière révision en **2024**.

Ce qui est en **gras** est à savoir par cœur. À l'épreuve, un texte se cite avec **son nom et sa date** ; si l'on doute du numéro d'article, on cite le principe et le texte général.

1. Morale, éthique, déontologie, droit (6.3.1)

Niveau	Définition	Exemple
Morale	Valeurs et normes qui distinguent le bien du mal, souvent vécues comme évidentes	« On ne ment pas »
Éthique	**Réflexion critique** sur ces valeurs face à une **situation concrète** : « Que faut-il faire ici, et pourquoi ? »	Respecter le choix d'une personne ou la protéger ?
Déontologie	**Devoirs d'une profession** (grec *deon*, « ce qu'il faut faire »)	Charte AFDN 2018
Droit	Règles **obligatoires et sanctionnées** par l'État	CSP, Code pénal, Code civil, RGPD

Les quatre niveaux s'emboîtent : une conduite peut être **légale mais discutable** (campagne culpabilisante) ou **exigée par la déontologie au-delà de la loi** (se former en continu).

Définition opérationnelle de l'éthique : démarche de questionnement et de délibération pour trouver, dans une situation donnée, la conduite **la plus juste**, en tenant compte des valeurs, des règles et des conséquences pour chaque personne. « Je trouve que » n'est **pas** une argumentation éthique : le jury attend des **principes nommés**, des **faits vérifiés** et des **conséquences**.

Trois façons de raisonner :

Courant	Question	Auteurs	Exemple	Limite
Conséquences (utilitarisme)	Quelle action fait le plus de bien et le moins de mal ?	**Bentham 1789**, **Mill 1861**	Taxe soda justifiée si elle réduit les maladies	Peut sacrifier une minorité
Devoir (déontologisme)	Quelle règle respecter, quelles que soient les conséquences ?	**Kant 1785**	On ne ment pas à un participant pour le motiver	Rigidité, devoirs qui s'opposent
Vertus	Que ferait un professionnel prudent et bienveillant ?	**Aristote** (*Éthique à Nicomaque*)	Adapter son conseil avec tact	Moins de règles précises

Kant : traiter l'humanité « **toujours comme une fin, et jamais simplement comme un moyen** ». **Aristote** : la **prudence** (*phronesis*), juger ce qui convient ici. Les 4 principes de Beauchamp et Childress empruntent aux trois courants. **Une décision solide combine les trois** (exemple du ketchup à la cantine : pesée des restes, devoir de servir des repas conformes et d'associer les élèves, solution mesurée avec une sauce maison).

Repères historiques (l'éthique en santé est née de scandales) :

Date	Texte ou événement	Apport
Ve s. av. J.-C.	Serment d'Hippocrate	Ne pas nuire, secret
1947	**Code de Nuremberg** (procès des médecins nazis)	Consentement volontaire « absolument essentiel »
1948	DUDH	Dignité ; droit à l'alimentation (art. 25)
1964	**Déclaration d'Helsinki** (révisée, dernière version 2024)	Protocole, avis d'un comité, consentement
1979	**Rapport Belmont** (après **Tuskegee**, 1932-1972)	Respect des personnes, bienfaisance, justice
1979	**Beauchamp et Childress**	Les 4 principes
1983	Création du **CCNE**	Avis éthiques nationaux
1988	Loi Huriet-Sérusclat	Premier cadre français de la recherche
2002	Loi du **4 mars 2002**	Information, consentement, dossier
2012	**Loi Jardé** (appliquée en novembre 2016)	Recherches impliquant la personne humaine

Tuskegee : des hommes noirs atteints de syphilis suivis sans information ni traitement, même après la pénicilline. **En nutrition** : expériences sur des enfants autochtones sous-alimentés au Canada (1942-1952), révélées par Ian **Mosby (2013)**. Les plus vulnérables sont les premiers exposés : **la protection doit être plus forte pour eux**.

2. Les principes éthiques (6.3.2)

Les 4 principes de Beauchamp et Childress (1979), **non hiérarchisés a priori** (on les arbitre au cas par cas) :

Principe	Sens	En nutrition
Autonomie	Respecter la capacité de décider	Informer clairement, consentement libre, ne pas manipuler, liberté de participer
Bienfaisance	Agir pour le bien	Actions utiles, fondées sur un diagnostic et des preuves
Non-malfaisance	*Primum non nocere*	Pas de stigmatisation, de culpabilisation, de restriction, de TCA, de surmédicalisation

Principe	Sens	En nutrition
Justice	Répartir selon les besoins	Ne pas creuser les inégalités (**universalisme proportionné**, chapitre 2)

Les 5 conditions de Childress et coll. (2002) pour justifier une mesure qui **restreint les libertés**, examinées **dans l'ordre** (si la mesure est inefficace, inutile d'aller plus loin) :

1. **Efficacité** : chances raisonnables d'atteindre l'objectif ?
2. **Proportionnalité** : bénéfices > atteintes aux libertés et effets négatifs ?
3. **Nécessité** : pas de moyen moins contraignant ?
4. **Moindre atteinte** : la modalité la moins intrusive (informer avant d'interdire) ?
5. **Justification publique** : choix expliqués de façon transparente ?

Exemple du self : supprimer les desserts sucrés n'est **pas justifié** (efficacité douteuse, autres moyens existent). Mettre les fruits en premier au prix le plus bas fait passer leur part de **30 % à 41 %** des 420 desserts : 126 → 172 fruits, **+ 36,7 %**, 46 desserts sucrés évités par jour, **920 par mois**, sans rien interdire.

L'échelle d'intervention (Nuffield Council on Bioethics, 2007), du moins au plus intrusif : **1. ne rien faire ou surveiller · 2. informer, éduquer · 3. faciliter les choix · 4. orienter par défaut · 5. inciter · 6. désinciter · 7. restreindre · 8. éliminer le choix**.

Échelon	Exemple
2 Informer	Campagnes PNNS, ateliers, **Nutri-Score**
4 Par défaut (nudge)	Légumes servis d'office, **eau en carafe**
5 Inciter	**Chèques fruits et légumes**
6 Désinciter	**Contribution boissons sucrées** (2012 ; progressive 2018 ; relevée le 1er mars 2025)
7 Restreindre	**Distributeurs payants interdits dans les écoles depuis le 1er septembre 2005**

Plus on monte, plus la justification doit être forte. Le diététicien agit surtout aux échelons 2 à 4 et peut faire du **plaidoyer** pour des mesures plus contraignantes.

Nudge (Thaler et Sunstein, 2008) : modifier l'**architecture du choix** pour orienter sans interdire ni changer vraiment les prix (fruits à hauteur des yeux, eau en carafe) = **paternalisme libéral**. Conditions éthiques : **transparence, réversibilité, finalité de santé (pas commerciale), équité**.

Trois paternalismes : **fort** (imposer un choix à un adulte capable, par exemple interdire les sodas : rarement justifiable) · **faible** (protéger quand le choix n'est pas libre, par exemple encadrer la publicité pour enfants : accepté) · **libéral** (nudge : accepté s'il est transparent). Exiger un atelier pour obtenir une aide alimentaire = paternalisme fort, **non justifiable**.

Mill (*De la liberté*, 1859) : on ne limite la liberté que pour **empêcher de nuire à autrui**. Objections en nutrition : choix influencés par le marketing et le prix, coût collectif des maladies, enfants à protéger.

Principe de précaution : dommage **grave et irréversible** possible + incertitude scientifique → mesures **proportionnées et provisoires**, avec recherche (**article 5 de la Charte de l'environnement, 2004**, valeur constitutionnelle ; exemple : bisphénol A, loi du 24 décembre 2012). ≠ **prévention** (risque connu : sel et hypertension). « Par précaution, évitez tous les laitages » n'est **pas** le principe de précaution.

Stigmatisation du poids : déclaration de consensus de **36 experts (Rubino et coll., *Nature Medicine*, 2020)** : le poids ne dépend pas que de la volonté. Conséquences : **évitement des soins**, moins bons soins, dépression, faible estime de soi, **plus de TCA et de prise de poids**. Contraire à la non-malfaisance **et inefficace**. Les professionnels ont aussi des préjugés implicites : s'examiner en analyse de pratique.

6 réflexes pour communiquer sans stigmatiser : parler de **comportements et d'environnements** (« personnes en situation d'obésité ») · images respectueuses, **avec un visage** · valoriser plaisir et santé, pas la minceur · **jamais de pesée en public** · pas de vocabulaire moral (bon/mauvais, tricher, craquer) · rappeler les déterminants collectifs. Matériel adapté à toutes les corpulences. Même réflexe pour la précarité, l'origine, l'âge.

Analyser une action en 4 angles : décrire en une phrase → autonomie → bienfaisance → non-malfaisance → justice → **nommer la tension principale et proposer un ajustement**. Exemple des paniers fruits et légumes « sur ordonnance » : tension justice (cibler les modestes) / non-malfaisance (ne pas les désigner) → dispositif ouvert à tous, **tarif modulé selon le quotient familial**.

Posture professionnelle (guide 2025) : **équité** (plus d'aide à qui en a besoin) · **justice sociale** (prix, horaires, langue, accès sans numérique) · **bienveillance** (accueillir sans juger) · **autonomie individuelle et de groupe** (proposer sans imposer, respecter un refus). Le savoir-être se travaille : enregistrement avec accord, retour d'un pair, journal.

3. Le cadre professionnel du diététicien (6.3.3)

Texte	Contenu
L. 4371-1 CSP	Définition : conseils nutritionnels ; sur **prescription médicale**, éducation et rééducation nutritionnelle ; qualité de l'alimentation en collectivité ; **prévention en santé publique**
L. 4371-2 et suivants	**Titre réservé** aux diplômés (BTS Diététique et nutrition, BUT génie biologique parcours diététique, diplômes européens autorisés)
Enregistrement	Obligatoire auprès de l'**ARS** avant d'exercer
Usurpation de titre	**Délit** (article 433-17 du Code pénal)
Déontologie	**Charte AFDN du 1er janvier 2018** ; **pas d'ordre** ; sert de référence en cas de litige

Titre protégé, pas monopole : d'autres professionnels formés peuvent parler d'alimentation dans leur champ. « **Nutritionniste** » seul n'est **pas protégé** (sauf médecin nutritionniste), pas plus que « coach » ou « naturopathe ». Régime pour une pathologie : diététicien sur **prescription** (le diagnostic relève du médecin). Anorexie sévère : **prise en charge pluriprofessionnelle**, orienter vite.

Les grands devoirs : respect de la personne et **non-discrimination** · **secret** · **compétence et mise à jour** · **indépendance** (déclarer ses liens) · **information loyale** · **orientation** (TCA, pathologie, perte de poids inexpliquée, détresse) avec l'accord de la personne · **confraternité et coopération**. Neutralité religieuse et politique en service public (le stagiaire adopte la même réserve).

DPC (développement professionnel continu) : formation continue obligatoire sur **3 ans** (formation, évaluation des pratiques, gestion des risques) ; loi du 21 juillet 2009, réorganisée en 2016.

Discrimination (article 225-1 du Code pénal) : distinction fondée sur un critère interdit (origine, sexe, **apparence physique**, **état de santé**, handicap, religion, lieu de résidence, **vulnérabilité économique**…) ; refuser un service : **3 ans et 45 000 €** (article 225-2). **Directe** (refuser une adolescente à cause de son poids) ou **indirecte** (inscriptions **uniquement en ligne**, ateliers uniquement à 10 h en semaine). Atelier réservé aux diabétiques : **pas** de discrimination (objectif légitime, proportionné).

Calcul de discrimination indirecte : 18 % du quartier sans internet, 50 inscrits en ligne → on attendrait **50 × 0,18 = 9** inscrits sans internet ; on en observe 0 → ajouter téléphone, accueil, travailleurs sociaux.

Huit situations commentées : petit cadeau symbolique accepté et partagé, cadeau de valeur refusé · pas de conseil individualisé sans bilan sur un réseau · erreur d'une collègue : lui en parler **en privé**, avec la source · prescription inadaptée : **contacter le médecin**, ne pas la modifier seul · refuser de vendre des compléments · se former avant un thème mal maîtrisé · personne qui refuse vos conseils : expliquer, laisser la porte ouverte, informer le médecin si danger et avec son accord · fatigue : pause, cadre, analyse de pratique.

3 questions avant d'agir : **Est-ce légal ? Est-ce conforme à ma déontologie ? Serais-je à l'aise si ma décision était connue ?** Un « non » ou « je ne sais pas » → je demande conseil. Confraternité : ne jamais dénigrer un collègue devant le public ; construire les menus **avec le cuisinier**.

4. Le secret professionnel et la confidentialité (6.3.4)

Secret professionnel : ne pas révéler les informations connues dans l'exercice de la profession. **L. 1110-4 CSP** (loi du 4 mars 2002) : droit au respect de la vie privée et au secret. Violation : **1 an et 15 000 €** (**article 226-13 du Code pénal**).

Le secret **appartient à la personne**, pas au professionnel. Il couvre ce qui est **confié**, **observé** (participante très amaigrie), **déduit** (présence à un atelier « diabète ») et l'**identité** des personnes accompagnées. À la voisine qui demande si Mme D. vient pour son diabète : on **ne confirme ni n'infirme**.

Cadre de confidentialité, rappelé à chaque séance : « Ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe. Personne n'est obligé de répondre ou de goûter. On ne juge pas. »

Situation	Conduite
Diagnostic confié en atelier	Reste dans le groupe
Partenaire : « qui a des problèmes de poids ? »	**Données agrégées et anonymes** (« 8 sur 12 »)
Difficultés financières confiées	En privé, orientation (CCAS, épicerie solidaire) avec accord
Enfant en danger	Le secret ne s'y oppose pas : responsable sans délai, **information préoccupante (CRIP)** ou **119** ; **17** si danger immédiat
Employeur qui veut savoir si son salarié vient	**Se taire** (sauf accord du salarié)

Dérogations : **obligation de déclarer** (maladies à déclaration obligatoire dont la **TIAC**) · **permission de signaler** les privations ou sévices sur un **mineur** ou une personne qui ne peut pas se protéger, et certaines violences conjugales (**article 226-14**) ; signalement de bonne foi **sans sanction** · **obligation de porter secours** (article 223-6, non-assistance) · **partage en équipe** du strict nécessaire, personne informée qui peut s'opposer (L. 1110-4).

Discrétion n'est pas secret : le stagiaire, l'animateur ou le bénévole ne sont pas toujours soumis au secret pénal, mais sont tenus à la **discrétion** par leur convention ou leur contrat. En pratique, même conduite.

Partager en équipe et en réseau : 3 règles : **personne informée · strict nécessaire · seulement à ceux qui en ont besoin pour l'aider**. Équipe de soins (L. 1110-4, L. 1110-12) : personne informée, peut s'opposer. **Hors équipe de soins** (santé ↔ social) : **consentement préalable**. Action sociale (L. 121-6-2 CASF) et protection de l'enfance (L. 226-2-2 CASF) : partage limité, dans l'intérêt de la personne ou de l'enfant.

Méthode avant de transmettre : **Pourquoi ? À qui ? Quoi (le minimum) ? Avec quel accord ? Comment (moyen sécurisé) ? Trace.** Jamais de nom ni d'information de santé dans un **groupe de discussion grand public** : utiliser une messagerie sécurisée de santé (**MSSanté**). Exemple : « Mme R. a des difficultés pour nourrir sa famille et elle est d'accord pour qu'on l'aide à accéder à l'épicerie solidaire », rien de plus.

5. La protection des données personnelles (6.3.5)

RGPD : **règlement (UE) 2016/679** du 27 avril 2016, **applicable depuis le 25 mai 2018** ; complète la **loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978** ; contrôle par la **CNIL** (créée en 1978).

- **Donnée personnelle** : se rapporte à une personne identifiée ou **identifiable**, directement (nom) ou **indirectement** (âge + école + quartier).
- **Donnée de santé** : **catégorie particulière (article 9)**, traitement interdit sauf exceptions ; poids, pathologies, allergies, régimes médicaux en font partie.
- **Pseudonymisation** : nom remplacé par un code ; **données encore personnelles** (clé).
- **Anonymisation** : réidentification **impossible et irréversible** ; **hors RGPD**.

Les 6 principes : **1. licéité, loyauté, transparence · 2. limitation des finalités · 3. minimisation · 4. exactitude · 5. limitation de la conservation · 6. intégrité et confidentialité**, + **responsabilité** (*accountability* : prouver sa conformité, registre).

Droits des personnes : information, accès et rectification, effacement, opposition, **retrait du consentement** (aussi facile que de le donner), réclamation à la CNIL.

Les 6 bases légales (article 6) :

Base	Exemple
Consentement	Lettre d'information, **photos**
Contrat	Inscriptions payantes à des ateliers
Obligation légale	Factures ; déclaration d'une TIAC
Intérêts vitaux	Transmettre une allergie aux secours
Mission d'intérêt public	Enquête d'une mairie ou d'un hôpital
Intérêt légitime	Association qui évalue la satisfaction de ses adhérents

Pour les **données de santé**, il faut **en plus** une exception de l'article 9 (consentement explicite, prise en charge par un professionnel tenu au secret, intérêt public en santé, recherche encadrée). **Le consentement n'est pas valable quand on n'est pas libre de refuser** (employeur, service public) : on s'appuie sur une autre base, en laissant libre de répondre.

Mention d'information : anonyme ou non, finalité unique, qui saisit, destruction des papiers, **date de suppression**, caractère **facultatif**, contact. Exemple de date : épreuve le 15 juin 2028 + 3 mois = **15 septembre 2028**.

Fiche du registre (article 30) : nom et responsable · finalité · base légale · personnes et données · destinataires · durée · sécurité · transferts hors UE.

Sécurité au quotidien (les incidents viennent surtout d'**erreurs humaines**) : fichiers **chiffrés**, pas de données de santé sur une clé personnelle · mots de passe robustes · fichier protégé et mot de passe envoyé par un **autre canal** · pas de lien « accessible à toute personne disposant du lien » · urne fermée, armoire, **broyeur** · hébergement dans l'**UE**. Relier deux questionnaires sans nom : **code personnel** (« MA14 ») ou table de correspondance gardée à part puis détruite.

Violation de données : registre interne ; **notification à la CNIL sous 72 heures** (article 33), sauf absence de risque ; **information des personnes** si risque élevé (article 34). Le stagiaire prévient **immédiatement** tuteur et **DPO**. Exemple : découverte jeudi 9 septembre 2027 à 16 h → limite **dimanche 12 septembre 16 h**.

Sanctions : jusqu'à **20 M€ ou 4 % du chiffre d'affaires mondial, le plus élevé** (article 83). CA 300 M€ → 12 M€ < 20 → **20 M€** ; CA 2 Md€ → **80 M€** ; CA 650 M€ → **26 M€**.

DPO obligatoire pour les organismes publics et ceux qui traitent des données sensibles à grande échelle. **AIPD (article 35)** si risque élevé : en principe dès **2 critères CNIL** (données sensibles, personnes vulnérables, grande échelle, croisement, usage innovant, suivi systématique). Données de santé hébergées en ligne : hébergeur certifié **HDS**.

Minimisation en 3 questions : vais-je utiliser la réponse ? Puis-je la demander moins précisément (**tranche d'âge**, quartier) ? Peut-elle gêner ou désigner ? Poids et taille dans un questionnaire de satisfaction : **à supprimer**.

6. Le consentement et le droit à l'image (6.3.6)

Participer est libre : on informe (objectifs, déroulement, **allergènes**, données) ; accord oral pour un atelier, **écrit** pour une enquête ou des photos ; retrait à tout moment **sans conséquence**. Mineur : accord des titulaires de l'autorité parentale **et avis de l'enfant (assentiment)**. Une évaluation d'atelier n'est **pas** une recherche (loi Jardé, **5 mars 2012**) ; si le but devient une publication, un **CPP** peut être nécessaire.

Droit à l'image : chacun peut s'opposer à la prise et à la diffusion de son image (**article 9 du Code civil**) ; capter ou diffuser l'image dans un lieu privé sans accord : **article 226-1 du Code pénal**.

L'autorisation : identité (et représentants légaux) · contexte · **supports cochés un par un** · durée et territoire · gratuité · **retrait possible** · signature (pour un mineur : **les deux titulaires de l'autorité parentale**, avec l'avis de l'enfant). Astuce : photos de **mains, de plats, de dos** ; flouter si l'accord manque.

4 qualités d'un consentement valable (RGPD, articles 4 et 7) : **libre** (refus sans conséquence) · **spécifique** (une case par usage) · **éclairé** (qui, quoi, pourquoi, combien de temps, droits) · **univoque** (acte positif : **case pré-cochée, silence = non**). + **retirable** et **prouvable**.

Âge du consentement numérique : 15 ans en France (loi du 20 juin 2018) ; en dessous, accord conjoint du mineur et des parents.

Consentement à l'oral pour ceux qui lisent peu : dire le but · dire les usages · dire la liberté · **faire dire** · formulaire simplifié avec pictogrammes, croix devant témoin · **pastille discrète** pour ceux qui refusent.

Situation	Autorisation ?
Atelier, personnes reconnaissables	**Oui**, de chacune, par support
Foule sans personne isolée	En principe non
Personne de dos sans signe distinctif	En principe non (attention tatouages, vêtements)
Élu à l'inauguration	Non pour informer sur l'événement, sans détournement
Enfant	**Oui, les deux parents + avis de l'enfant** (**loi du 19 février 2024**)
Image modifiée par IA	**Oui** ; montage diffusé sans accord sanctionné (**226-8**, loi SREN du **21 mai 2024**)

Avant/après : même avec accord, **problème éthique** (apparence, stigmatisation, régimes dangereux) ; valoriser les comportements et le plaisir. **Durée** : tableau de suivi des photos ; autorisation de 2 ans du 22 mars 2027 → fin le **22 mars 2029** ; retrait = effet **pour l'avenir**.

7. Les conflits d’intérêts (6.3.7)

Conflit d’intérêts : un **intérêt secondaire** (financier, professionnel, personnel) peut influencer **ou paraître influencer** le jugement (intérêt primaire : la santé). **Le lien d’intérêts n’est pas une faute** ; c’est **ne pas le déclarer ni le gérer** qui pose problème.

Proposition	Conduite
Marque de yaourts : ingrédients contre logo	Refuser ou négocier : sans logo ni produit, **convention**, mention transparente, contenu décidé par le diététicien
Échantillons de lait infantile	**Refuser** : **Code international OMS de 1981** (substituts du lait maternel)
Bon d’achat d’un supermarché	Acceptable sans promotion ; préférer épicerie solidaire, marché
Diététicien libéral en atelier municipal	Pas de promotion de son cabinet ; liste de plusieurs professionnels
Supports d’une association de producteurs	Vérifier exactitude et neutralité ; préférer Santé publique France

Règles : **encadrement des avantages** (« loi anti-cadeaux » **1993**, refondue en **2017**) : pas d’avantage aux professionnels de santé **ni aux étudiants**, sauf exceptions encadrées (activité réelle rémunérée, hospitalité raisonnable en congrès, dons pour la recherche), déclarées ou autorisées · **Transparence Santé** (**loi Bertrand du 29 décembre 2011**) : conventions et avantages publiés **dès 10 €**. Les experts de l’Anses et de la HAS remplissent une déclaration publique d’intérêts.

Biais de réciprocité : on veut rendre ce qu’on a reçu, même un petit cadeau, souvent sans s’en rendre compte.

Gérer une sollicitation en 6 étapes : **identifier · vérifier le cadre · évaluer l’effet · décider · déclarer · tracer**. Repas offert par un laboratoire après une présentation : **refuser** ; atelier rémunéré en pharmacie, thème libre, sans promotion : **possible** avec convention.

Financement et biais : **Lesser et coll., *PLoS Medicine*, 2007** : études sur les boissons financées par l’industrie **4 à 8 fois** plus souvent favorables · **Kearns, Schmidt et Glantz, *JAMA Internal Medicine*, 2016** : l’industrie sucrière a financé dans les années 1960 une revue qui minimisait le rôle du sucre. Lecture critique : **qui finance ? liens des auteurs ? rôle du financeur ? concordance avec d’autres études ? qui diffuse ?** Privilégier les **avis des agences** (Anses, EFSA, HCSP), datés.

8. Une démarche de réflexion éthique (6.3.8)

La grille en 5 étapes : **1. Faits** (sans jugement) · **2. Règles** (droit, déontologie, structure) · **3. Valeurs en tension** · **4. Options** (**au moins 3**, pour sortir du tout ou rien) · **5. Décision** justifiée, **partagée** (tuteur, équipe), **tracée** et **réévaluée**.

Exemple de la mère qui veut « peser tous les enfants » : peser en public (rejeté), refuser sèchement (rejeté), **expliquer et orienter vers le médecin, la PMI ou la santé scolaire** (retenu).

Exemple rédigé : viennoiseries à l’épicerie solidaire (60 kg par semaine) : règles = **loi Garot du 11 février 2016** (les grandes surfaces proposent leurs invendus aux associations), **L. 266-1 CASF** (aide alimentaire diversifiée, digne), hygiène ; options : tout refuser / tout mettre en rayon / **accepter en quantité raisonnable par passage, redistribuer le surplus, négocier des produits frais, proposer un atelier goûters libre** → décision évaluée à 3 mois.

Rédiger à l’écrit : une phrase qui nomme le dilemme · un paragraphe par étape · principes nommés, textes datés · 3 options avec avantage et limite · décision (qui, quand, comment) + évaluation · conclusion sur le partage en équipe. Connecteurs pour **nuancer** : « dans la mesure où », « à condition que », « sauf si ».

Les lieux : équipe (analyse de pratique, supervision) · comité d’éthique d’établissement · **ERER** (espace de réflexion éthique régional) · **CCNE** (1983, avis nationaux, états généraux de la bioéthique). **Avis consultatifs** : la responsabilité reste aux professionnels.

Journal de bord : date et contexte · situation · ce que j’ai fait · principes en jeu · ce que j’en retiens · avec qui j’en ai parlé ; **aucune donnée identifiante** (« une participante »).

9. Les droits des usagers et la démocratie en santé (6.3.9)

Texte	Apport
DUDH 1948, art. 25	Niveau de vie suffisant, dont l’alimentation

Texte	Apport
PIDESC 1966, art. 11	Droit à une nourriture suffisante, à l'abri de la faim
Loi du 2 janvier 2002	Établissements sociaux et médico-sociaux : livret d'accueil, contrat de séjour, **CVS**, projet personnalisé ; charte de la personne accueillie (2003)
Loi du 4 mars 2002	Information, consentement, accès au dossier, secret, représentants des usagers
EGalim 2018, L. 266-1 CASF	Précarité alimentaire : alimentation sûre, diversifiée, de qualité, **dans le respect de la dignité** et de la **capacité à agir**
Loi du 26 janvier 2016	Démocratie sanitaire : conseils territoriaux de santé, médiation
Loi HPST, 21 juillet 2009	Crée les **ARS** et les **CRSA**

Démocratie en santé : associer usagers et citoyens aux politiques de santé (CRSA, conseils territoriaux, **CDU**, **CVS**). Aide alimentaire digne : **choix des produits** (épicerie solidaire plutôt que colis imposés), participation symbolique, pas de leçon.

Fin de vie : **personne de confiance** (loi de 2002, élargie au médico-social en 2015) témoigne de la volonté · **directives anticipées** (loi du 22 avril 2005, renforcées en 2016) · **procédure collégiale**. **Loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016** : **nutrition et hydratation artificielles = traitements**, qui peuvent être limités ou arrêtés s'ils sont inutiles ou disproportionnés. **Alimentation plaisir = soin de confort**, toujours proposée si la personne le souhaite. **Forcer à manger n'est jamais acceptable.**

Refus alimentaire d'une personne âgée : chercher une **cause traitable** (dents, déglutition, douleur, dépression, médicaments) · adapter l'offre (goûts, textures, horaires, enrichissement, aide au repas) · écouter · associer personne de confiance et famille **sans leur transférer la décision** · décider en équipe, comité d'éthique si désaccord · **respecter la volonté** d'une personne capable, avec soins de confort.

Instances : **CDU** (établissements de santé, a remplacé la CRUQPC en 2016 : plaintes, réclamations, amélioration, y compris des repas) · **CVS** · commission des menus · conseil territorial de santé. **Charte de la personne hospitalisée** (circulaire du **2 mars 2006**). **Patient partenaire** : savoir expérientiel, co-animation, relecture des supports.

Calcul de réclamations : 54 / 240 = **22,5 %** concernent les repas ; température 23 / 54 = **42,6 %** → priorité à la distribution (chariots chauffants). EHPAD : 30 réponses sur 80 = **37,5 %** de réponse (représentativité limitée) ; 21 / 30 = **70 %** veulent un choix le soir.

Droit à l'oubli : **5 ans** après la fin du protocole sans rechute (cancer, hépatite C), **loi Lemoine 2022** ; convention **AERAS** pour les autres maladies. **Action de groupe** : régime unique depuis la **loi du 30 avril 2025**.

10. La responsabilité du professionnel (6.3.10)

Responsabilité	Principe
Civile	**Réparer** un dommage (**articles 1240 et 1241 du Code civil**) : **faute + dommage + lien de causalité** ; couverte par l'assurance
Pénale	Sanctionner une **infraction** : blessures involontaires, mise en danger, violation du secret, non-assistance
Disciplinaire	Employeur (règlement, fiche de poste) ; ordre professionnel (**pas pour les diététiciens**)

Obligation de moyens (tout faire sans garantir le résultat : on ne promet pas une perte de poids) ≠ **obligation de sécurité** (aliments servis sains, matériel en bon état). **Faute** (allergie connue non prise en compte) ≠ **aléa** (chute sous surveillance normale). **Assurance RC professionnelle obligatoire pour les libéraux** (**L. 1142-2 CSP**) ; salarié couvert par l'employeur ; stagiaire selon la **convention tripartite**. Le stagiaire ne fait **jamais seul** une activité à risque (four, enfants) et signale tout incident.

Risques en atelier : **allergie** (recueil écrit, **14 allergènes affichés**, étiquettes lues le jour même, variantes, **15 ou 112** affichés) · **TIAC** (au moins **2 cas groupés**, symptômes similaires, même origine alimentaire ; **déclaration obligatoire à l'ARS**) · brûlures et coupures (**1 animateur pour 4 à 6**, plus avec des enfants) · chute, malaise · enfants (autorisation, tâches adaptées).

Encadrement : arrondir à l'entier supérieur : 14 enfants / 4 = 3,5 → **4 adultes** ; 18 / 5 = 3,6 → **4** ; 23 / 5 = 4,6 → **5**.

Les 14 allergènes : **gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, sulfites (> 10 mg/kg ou /L), lupin, mollusques** (règlement **1169/2011** ; non préemballés : décret du 17 avril 2015).

PAI (projet d'accueil individualisé) : rédigé à la demande de la famille avec le médecin ; aménagements et **protocole d'urgence**. **Jamais de liste nominative des enfants allergiques affichée** au réfectoire : classeur à l'office, accessible aux seuls agents, repère discret, mise à jour. Dégustation : supprimer la recette à l'arachide (risque de contamination pour tout le groupe).

11. Publicité, allégations et compléments (6.3.11)

Allégations nutritionnelles (règlement (CE) 1924/2006) : seules les allégations des listes autorisées.

Allégation	Condition
Source de fibres	**≥ 3 g/100 g** ou ≥ 1,5 g/100 kcal
Riche en fibres	**≥ 6 g/100 g** ou ≥ 3 g/100 kcal
Source de protéines	**≥ 12 %** de l'énergie
Riche en protéines	**≥ 20 %** de l'énergie
Sans sucres ajoutés	Aucun sucre ni denrée édulcorante ajoutés
Allégé, réduit en	**≥ 30 %** de moins (25 % pour le sel)
Faible teneur en sel	≤ 0,12 g de sodium/100 g (≈ 0,3 g de sel)

Allégations de santé : autorisées par la Commission après avis de l'**EFSA**, registre de l'Union. Aucun aliment ne peut prétendre **prévenir ou guérir** une maladie (sauf réduction de risque autorisée au cas par cas).

Calcul : biscuit « riche en fibres » à 5,2 g/100 g et 460 kcal → 5,2 < 6 et 1,13 g/100 kcal < 3 → **non conforme** ; « source de fibres » possible. Protéines : 7,5 × 4 = 30 kcal → **6,5 %** < 12 %. Signalement : **DGCCRF** (plateforme **SignalConso**).

Publicité : loi de **2004** et **décret du 27 février 2007** : message sanitaire (« Pour votre santé… ») + **mangerbouger.fr**, ou contribution à Santé publique France. Efficacité limitée ; encadrement plus strict demandé par le HCSP et l'OMS.

Compléments alimentaires (directive **2002/46/CE**, **décret 2006-352**) : denrées en doses, **pas des médicaments**, aucune promesse de prévention ou de guérison ; **déclarés** à la DGCCRF (pas d'autorisation de mise sur le marché) ; **nutrivigilance de l'Anses**. Supplémentation justifiée : **B12** chez le végétalien, **vitamine D** sur avis médical, **acide folique** avant la conception.

Nutri-Score : arrêté du **31 octobre 2017** ; **facultatif** (le droit européen ne permet pas de l'imposer seul) ; algorithme révisé (2022 aliments, 2023 boissons), applicable par l'**arrêté du 14 mars 2025**. Échelon **« informer »** : respecte l'autonomie et aide la justice (lisible en littératie limitée). Limites : facultatif, ne compare que des produits **d'un même rayon**, ignore la transformation et les additifs. **Outil de comparaison, pas un jugement moral** (« Mangez A, évitez E ! » est inexact et culpabilisant). Céréales chocolatées : 28 × 40 / 100 = **11,2 g** de sucres par portion ≈ **2 morceaux de 5 g**, contre 0,4 g pour les flocons d'avoine.

Marketing des emballages : « naturel », « authentique » : **pas de définition**, interdit seulement si trompeur · « **fait maison** » : décret de **2015**, restauration seulement · **bio** : mode de production, pas meilleure composition · « sans colorants » : vrai mais peut masquer le sucre · personnages de dessins animés : non interdits sur les emballages. **Pratique commerciale trompeuse** : articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation. Boisson à **6 %** de jus en 1,5 L = **90 mL**, moins d'un demi-verre.

Risques des compléments : surdosage (vitamine D chez le nourrisson, alerte Anses 2021), interactions (**millepertuis** et contraceptifs, anticoagulants), populations sensibles, produits « minceur » achetés hors UE, promesses « détox ». **Conseiller** : recenser sans juger · comprendre l'attente · informer loyalement · proposer des aliments · orienter · signaler (nutrivigilance). Vitamine C : besoin **110 mg/j** (Anses) ; une orange de 150 g ≈ 71 mg ; 100 g de poivron rouge = 121 mg ; un comprimé de 500 mg dépasse largement le besoin.

12. Enquêtes, recherche et protection des personnes (6.3.12)

Situation	Cadre
Questionnaire anonyme d'évaluation ou de diagnostic	**Hors loi Jardé** ; RGPD si données personnelles

Situation	Cadre
Recherche impliquant la personne humaine (RIPH)	**Avis d'un CPP**, protocole, consentement (ou non-opposition en catégorie 3) ; MR-001 à MR-003
Étude sur données existantes	RGPD ; **MR-004** de la CNIL ou autorisation
Mémoire d'étudiant	Souvent hors loi Jardé ; se renseigner

Les 3 catégories de RIPH (loi Jardé) :

Catégorie	Exemple	Accord
1 – Interventionnelle	Nouveau complément nutritionnel oral chez des patients dénutris	**Consentement écrit** (+ ANSM si produit de santé)
2 – Risques et contraintes minimes	Impédancemétrie, questionnaires répétés, petite prise de sang	Consentement exprès (écrit ou oral tracé)
3 – Non interventionnelle	Observer les consommations au repas	**Information et absence d'opposition**

Le **CPP** est désigné par **tirage au sort national** ; il réunit chercheurs, soignants et société civile. **Note d'information** : objectif, méthode, durée, bénéfices, risques, alternatives, avis du CPP, liberté d'arrêter, droits sur les données. Taux d'acceptation : 112 / 160 = **70 %** ; parmi ceux qui peuvent décider, 112 / 143 = **78,3 %**.

7 principes d'une enquête de terrain : finalité utile · information loyale · liberté de participer et d'arrêter · anonymat, minimisation · questions non intrusives · **restitution** · sécurité et suppression.

Intégrité scientifique (loi du **24 décembre 2020**) : **FFP = fabrication, falsification, plagiat**. Arrondir 66,67 % à 66,7 % : correct · retirer des réponses négatives : **falsification** · ajouter des questionnaires remplis soi-même : **fabrication** · copier un texte d'IA sans le dire : **plagiat**. Citer : auteur ou organisme, titre, année, date de consultation ; données fictives **signalées** ; aide d'une IA **signalée** et vérifiée. **Fraude à l'E5** : annulation, interdiction d'examen. Un résultat décevant présenté honnêtement (22 questionnaires sur 60 = 36,7 %, avec ses limites) est **valorisé**.

13. Identité numérique et e-réputation (6.3.13)

Identité numérique = traces en ligne ; **e-réputation** = image qui s'en dégage (compétence **C3.5**). Bonnes pratiques : comptes personnels et professionnels **séparés** · confidentialité paramétrée · **aucune photo ni donnée de participants** sans autorisation spécifique · contenus **sourcés et datés** · ne pas répondre à chaud · **mentionner tout partenariat** (**loi du 9 juin 2023** sur l'influence commerciale, modifiée par ordonnance du 6 novembre 2024) · vérifier ce qui apparaît à son nom.

Répondre à une fausse information en 4 temps : **1. reconnaître la préoccupation · 2. commencer par le fait exact (pas par le mythe, qui serait renforcé) · 3. expliquer pourquoi l'idée circule · 4. donner une source fiable et datée, proposer d'en reparler**. Indices d'une info douteuse : promesse rapide, aliment miracle ou poison, pas de source, **produit à vendre**, témoignages, discours anti-autorités. **On corrige l'information, pas la personne.**

Télésoin : **loi du 24 juillet 2019**, décret de 2021 ; proposer sans imposer, outil sécurisé, pièce fermée, **alternative en présentiel ou par téléphone**, compte rendu.

14. Dilemmes commentés (6.3.14)

Situation	Décision argumentée
Participant ivre	Lui parler **en privé**, l'éloigner du matériel dangereux, proposer de revenir, prévenir la référente
Mère qui refuse un voisin « d'une autre origine »	Rappeler calmement que l'atelier est **ouvert à tous** ; ne rien changer ; informer la référente
Financeur qui veut la liste nominative	**Données agrégées** ; émargements seulement si la convention l'exige et si les personnes sont informées
Avant/après publié avec accord	En parler à la collègue ; proposer un témoignage centré sur le **plaisir de cuisiner**
Ateliers réservés aux familles « qui le méritent »	**Critères de besoin transparents**, liste d'attente, cycle supplémentaire

Situation	Décision argumentée
Ado de 16 ans qui se fait vomir	Écouter, expliquer qu'on ne peut pas garder cela seul ; tuteur, infirmière ou médecin ; chercher **avec lui** comment informer ses parents et consulter
Élu qui veut photos et prénoms des familles « en difficulté »	Bilan **agrégé**, témoignages anonymes, photos de plats et de mains
Participante toujours en retard	Entretien pour comprendre, accueil adapté, cadre rappelé sans la désigner
Médecin : faire signer « sans trop expliquer »	**Refuser** un consentement non éclairé ; note d'information claire ; vérifier les autorisations
Relayer une campagne municipale avant une élection	**Pas sur ses comptes personnels** ; messages de santé sur les supports officiels

Principe dominant : quand il y a un **danger grave pour une personne vulnérable**, la **protection passe avant le secret**, en **informant la personne** de ce que l'on fait. Sans danger grave, **autonomie et dignité** priment. PMI : boisson végétale à la place du lait infantile chez un bébé de 4 mois → informer, chercher une solution compatible avec les convictions (allaitement, préparation infantile à protéines végétales sur avis médical), suivi rapproché ; **information préoccupante** si danger ou refus.

15. Laïcité, neutralité et menus végétariens (6.3.15)

Laïcité (**loi du 9 décembre 1905**, article 1er de la **Constitution de 1958**) : liberté de conscience et égalité.

Acteur	Obligation
Agents publics	**Stricte neutralité** religieuse et politique
Salariés privés en mission de service public	Neutralité depuis la **loi du 24 août 2021**
Salariés d'associations, entreprises	Liberté, sauf restrictions justifiées du règlement intérieur
Usagers	**Libres de leurs convictions** (élèves du public : loi du 15 mars 2004)
Stagiaire	Règles de la structure ; en structure publique, même réserve que les agents

Pas d'obligation légale de plat de substitution au porc, mais la collectivité qui change ses pratiques doit tenir compte de l'**intérêt des enfants** (**Conseil d'État, 2020**). Jeûne : adapter sans exiger ni décourager, sécurité. La laïcité **n'exclut pas** des pratiques alimentaires : recettes compatibles avec le plus grand nombre.

Menus végétariens : **EGalim 2018** (expérimentation hebdomadaire à l'école dès **novembre 2019**) · **loi Climat et résilience du 22 août 2021** (**pérennisation**, expérimentation d'une option quotidienne) · **option végétarienne quotidienne** dans la restauration de l'État dès le **1er janvier 2023**. Motif : protéines et environnement, **pas la laïcité**. Un menu végétarien doit être **équilibré** (légumineuses + céréales, œufs, laitages). Cycle de 20 repas : (4 + 6) / 20 = **50 %** avec un plat végétarien, 4 / 20 = **20 %** tout végétariens.

16. Fil rouge et cas guidé (6.3.16 et 6.3.17)

Inès aux Tilleuls : cadre de confidentialité, **données agrégées** · questionnaire **anonyme** (âge en tranches), papiers détruits, fichier protégé, **suppression le 15 septembre 2028** · images : **9 / 12** adultes ; enfants **7 / 15 = 46,7 %** → mains et plats, visages floutés · biscuits offerts par une marque **refusés** ; fruits de la supérette avec « avec le soutien de » · **aucune pesée** · 2 allergies (arachide, kiwi), brûlure légère consignée · biscuit « riche en fibres » à 4,8 g : **non conforme** (seuil 6 g), exercice de littératie · participation libre, sans condition d'accès à l'épicerie · rien sur ses comptes personnels.

Cas guidé : dénutrition des seniors (CCAS de Val-Fleuri, 140 bénéficiaires) : restes notés chaque jour, pesée tous les 3 mois, résultats aux médecins et familles, tablettes offertes par un fabricant de compléments **contre la liste des personnes « à risque »**.

- Bénéfices : repérage précoce (chutes, infections, hospitalisations). Risques : vie privée, contrôle, données de santé, transmission sans accord, **usage commercial**.
- Données de santé : finalité, **mission d'intérêt public + exception article 9**, information, **relevé simple** (« tout, la moitié, presque rien »), accès limité, durée ; **AIPD** (santé, vulnérables, suivi systématique), **DPO**.

- Médecin traitant hors équipe du CCAS → **accord de la personne** ; famille : **rien sans accord** (sauf mesure de protection).
- Consentement : oral + document en gros caractères, faire dire, accord écrit ; assentiment et personne de confiance si troubles cognitifs.
- Fabricant : **refuser** (secret, RGPD, promotion auprès de personnes vulnérables) ; autres financeurs (conférence des financeurs, caisses de retraite).
- Plus juste : relevé une semaine par mois, pesée annuelle si utile, livreurs formés, bénéficiaires associés, **réponses concrètes**. Charge : 140 × 4 × 0,5 h = **280 h/an** contre 98 × 0,5 = **49 h** : la proportionnalité, c'est aussi bien utiliser les ressources.

17. Approfondissements (6.4 et 6.5)

Réseaux sociaux : 5 règles : contenus sourcés · **pas de photo de participants sans autorisation spécifique aux réseaux** · signaler tout partenariat · pas de conseil individualisé en commentaire · pas d'avant/après. **Charte éditoriale** d'un compte de prévention : objectif, public, sources, ce qu'on ne publie pas, **relecture par une 2e personne**, modération (réponse sous **48 h ouvrées**), pas de partenariat commercial, pas de collecte de données. Vérifier une publication : exactitude, clarté (10 secondes), respect, image, **indépendance** (aucune marque visible), source. Taux de partage 12/180 = **6,7 %** ; l'audience **ne mesure pas** le changement de comportement.

Partenariats public-privé : risque de « **marketing de la bonne cause** » ; analyse de risque (OMS) : objectifs compatibles, **pas de promotion**, contenus maîtrisés, transparence, **possibilité de rompre**. **Grille sur 14** (7 critères notés 0-1-2) : **12-14 acceptable · 8-11 à négocier · < 8 ou un 0 en « cohérence » ou « données » = refus**. Mutuelle : 600 / 5 000 = 12 % → **12 points**, acceptable. Fast-food : 1 500 / 5 000 = 30 %, **7 points** + 0 en cohérence → **refus**. Appliquer la grille **avant** de connaître le montant.

Participation : **échelle d'Arnstein (1969)**, 8 barreaux : **non-participation** (manipulation, thérapie) · **participation symbolique** (information, consultation, conciliation) · **pouvoir effectif** (partenariat, délégation, contrôle citoyen). La plupart des projets sont aux barreaux **3-4** ; chercher à **monter d'un barreau**.

IA en santé : confidentialité (**aucune donnée personnelle**), exactitude (erreurs assurées, références inventées), biais culturels, **transparence**, **responsabilité du professionnel**. Niveaux du règlement 2024/1689 : **inacceptable** (notation sociale) · **élevé** (dispositifs médicaux, accès aux prestations) · **transparence** (dire qu'on parle à une IA) · minimal. Méthode : règles · aucune donnée perso · demande précise · **vérifier chaque information** · relire le ton · tester avec le public · être transparent. Exemple : « 5 fruits par jour, 3 L d'eau, zéro sucre » = **3 erreurs**.

Personnes vulnérables : rechercher l'**assentiment**, information adaptée (FALC). **Mesures de protection** : sauvegarde de justice · **curatelle** (assistance surtout pour les actes financiers) · **tutelle** (représentation) · habilitation familiale. La personne **décide seule de sa vie personnelle dans la mesure où son état le permet** : un curateur ne peut pas supprimer les desserts d'un adulte qui exprime ses choix.

Niveau L3 : **Rawls 1971** (inégalités acceptables si elles profitent aux plus défavorisés) · **Sen et Nussbaum** (**capabilités** : liberté réelle de convertir les ressources en santé) · débat sur le paternalisme · **éthique du care** (**Gilligan 1982**, Tronto) · **Habermas** (éthique de la discussion, délibération) · justice et **démocratie alimentaires**, sécurité sociale de l'alimentation (expérimentations, résultats en cours d'évaluation) · **One Health** (OMS, FAO, OMSA, PNUE) · **autonomie relationnelle** (Mackenzie et Stoljar, 2000).

18. Préparer l'épreuve E5

Méthode 1 : enjeux en 5 minutes : repérer les personnes, puis les **mots signaux** → **photo** = droit à l'image · **questionnaire nominatif** = RGPD · **logo, gratuit en échange de** = conflit d'intérêts · **confidence** = secret · **obligatoire** = autonomie · **poids** = non-malfaisance · **public modeste** = justice. Un paragraphe par enjeu : **notion, élément du document, risque, solution**.

Méthode 2 : justifier par un texte : nom + date si l'on est sûr ; sinon le principe et le texte général ; toujours **appliquer à la situation**. « Identifiez » = liste reliée au document · « Analysez » = causes, conséquences, tensions · « Justifiez » = principe ou texte appliqué · « Proposez » = actions concrètes (qui, quoi, quand) · « Rédigez » = texte prêt à l'emploi.

Méthode 3 : courrier de refus de partenariat : remercier · rappeler l'objectif et les principes · refuser clairement, sans juger · proposer une alternative (mécénat sans contrepartie) · politesse.

Méthode 4 : l'oral : « Quelles précautions éthiques ? » → **confidentialité, données, image, partenariat, non-stigmatisation, participation**, chacun avec un fait du projet, + **un dilemme vécu** et sa résolution avec le tuteur.

Méthode 7 : à qui s'adresser ?

Autorité	Pour quoi
CNIL (1978)	Violation de données, plainte
DGCCRF (DDPP, SignalConso)	Allégation interdite, pratique trompeuse, influence
ARS	**TIAC**, déclarations obligatoires, enregistrement des diplômes
Anses	**Nutrivigilance**
Défenseur des droits (2011)	Discrimination, droits de l'enfant
CRIP	Information préoccupante sur un mineur
Procureur	Danger grave et immédiat
CPP	Protocole de recherche

Sanction administrative (CNIL, préfet) ≠ **sanction pénale** (tribunal). Violation du secret, usurpation de titre, discrimination = **délits** (tribunal correctionnel).

19. Fiches-outils du chapitre

Outil	Contenu	Utilité
O6.1	Autorisation de droit à l'image (supports cochés un par un, 2 ans, gratuité, retrait, deux parents pour un mineur)	Avant toute photo ou vidéo
O6.2	Check-list RGPD (finalité, base légale, minimisation, santé justifiée, mention, facultatif, date de suppression, stockage, destruction, résultats agrégés, registre)	Avant une collecte
O6.3	Analyse d'un partenariat (qui, quoi, contrepartie, compatibilité, contenus, public vulnérable, convention, mention, alternatives, validation)	Avant d'accepter un soutien
O6.4	Grille d'analyse d'un dilemme en 5 étapes	Situation difficile en stage
O6.5	Check-list « message non stigmatisant » (comportements, plaisir, pas de vocabulaire moral, images, pas d'avant/après, déterminants, solutions accessibles, relu par le public)	Avant diffusion d'un support

20. Chiffres et dates à savoir

Repère	Valeur
Beauchamp et Childress	**1979** : autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice
Childress et coll.	**2002** : efficacité, proportionnalité, nécessité, moindre atteinte, justification publique
Nuffield	**2007** : échelle en 8 échelons
Nudge	Thaler et Sunstein **2008**
Nuremberg / Helsinki / Belmont	**1947** / **1964** (révisée 2024) / **1979**
CCNE	**1983**
Profession	**L. 4371-1 CSP** ; charte AFDN **2018** ; DPC sur **3 ans**
Secret	**L. 1110-4 CSP** ; **226-13** : **1 an, 15 000 €** ; 226-14 : signaler
Discrimination	225-1 ; 225-2 : **3 ans, 45 000 €**
RGPD	**2016/679**, **25 mai 2018** ; **72 h** ; **20 M€ ou 4 %** (le plus élevé)
Consentement numérique	**15 ans** (loi du 20 juin 2018)
Droit à l'image	**art. 9 Code civil** ; enfants : loi du **19 février 2024**

Repère	Valeur
Conflits d'intérêts	Code OMS **1981** ; loi Bertrand **29/12/2011** ; Transparence Santé **dès 10 €**
Influence	loi du **9 juin 2023**
Droits	lois du **2 janvier 2002** et du **4 mars 2002** ; HPST **2009** ; L. 266-1 CASF (EGalim **2018**)
Fin de vie	loi Claeys-Leonetti **2 février 2016** (nutrition artificielle = traitement)
Droit à l'oubli	**5 ans** (loi Lemoine **2022**)
Gaspillage	loi Garot **11 février 2016**
Allégations	**1924/2006** : source fibres 3 g, riche 6 g ; protéines 12 % / 20 % ; allégé 30 %
Compléments	directive 2002/46 ; **décret 2006-352** ; nutrivigilance Anses
Nutri-Score	arrêté **31/10/2017** ; révision applicable : arrêté **14/3/2025**
Recherche	loi **Jardé 2012** (appliquée 2016) ; 3 catégories ; CPP par tirage au sort
Intégrité	loi du **24 décembre 2020** ; FFP
Télésoin	loi du **24 juillet 2019**
Laïcité	**1905** ; loi du **24 août 2021** ; loi du **15 mars 2004**
Menus végétariens	EGalim **2018** (nov. 2019) ; Climat et résilience **22 août 2021** ; État **1/1/2023**
Arnstein	**1969**, 8 barreaux, 3 niveaux
IA	règlement **2024/1689** ; transparence depuis le **2 août 2026**

21. Les pièges

- Confondre **éthique et opinion** (« je trouve que ») ou éthique et application mécanique des règles.
- Croire que la justification doit **baisser** quand une mesure devient plus intrusive (c'est l'inverse).
- Croire qu'un **nudge interdit** ; oublier transparence et réversibilité.
- Confondre **précaution** (risque incertain) et **prévention** (risque connu).
- Croire que le titre de **nutritionniste** est protégé ; croire qu'il existe un **ordre** des diététiciens.
- Croire que le secret ne couvre que ce qui est **confié**, ou qu'il cesse quand la personne a parlé.
- Penser qu'un questionnaire **sans nom** est forcément anonyme ; croire que la **pseudonymisation** rend anonyme.
- Prendre le **consentement** comme base pour une enquête imposée par un employeur.
- Croire qu'**un seul parent** suffit pour diffuser la photo d'un enfant ; qu'une photo prise en public dispense d'autorisation.
- Utiliser une **case pré-cochée** ou une case unique « j'accepte tout ».
- Croire qu'un **lien d'intérêts est une faute** ; accepter des **échantillons de lait infantile** ou un repas offert par un laboratoire.
- Afficher une **liste nominative** d'enfants allergiques ; peser en public ; publier un **avant/après**.
- Croire que les compléments ont une **autorisation de mise sur le marché** comme les médicaments.
- Classer une évaluation d'atelier dans la **loi Jardé**.
- Croire qu'un **tuteur ou un curateur** décide des repas d'un adulte capable de choisir.
- Croire que la **laïcité** interdit les menus adaptés ou que les **usagers** sont tenus à la neutralité.
- Garder les anciens chiffres du CNED : droit à l'oubli **10 ans** (c'est 5 ans), loi « HSPT » (c'est HPST).